

Ingesta o aspiración de cuerpo extraño

1. Introducción y relevancia clínica

La **ingesta** y la **aspiración de cuerpos extraños (CE)** son urgencias frecuentes, con **pico en preescolares (1–3 años)** y en **adultos mayores** (prótesis dentales, trastornos neurológicos, alcohol/sedación). También ocurren en **jóvenes** por ocupaciones/aficiones (p. ej., clavos, alfileres) y en **pacientes psiquiátricos o privados de libertad**.

Aspiración traqueobronquial: causa **asfixia aguda** (mortalidad prehospitalaria).

Ingesta esofágica: puede complicarse con **necrosis** (pilas), **perforación** (huesos, alfileres) o **fístulas** (atrioesofágica), y neumonía por aspiración.

Relevancia para EUNACOM:

- Algoritmo **ABC** y **desobstrucción inmediata** (maniobras según edad).
 - Reconocer “**objetos tiempo-dependientes**”: **pilas tipo botón** y **imanes múltiples**.
 - Elección de **broncoscopía rígida** vs **flexible**, y coordinación ORL/broncoscopia/Gastroenterología.
 - Diferenciar clínica de **CE en vía aérea vs esófago**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Vía aérea (aspiración)

- Material penetra **laringe/tráquea**; si no se expulsa por tos, desciende a **árbol bronquial** (predomina **bronquio principal derecho** por ángulo más vertical).
- Obstrucción puede ser:
 - **Completa** (válvula de tapón): **apnea inmediata** → hipoxia → paro.
 - **Parcial**: efecto válvula (unidireccional), atrapamiento de aire y **hiperinflación** distal.

Respuesta refleja: tos, broncoespasmo, laringoespasmo. **Edema y granulación** aparecen en horas-días, dificultando extracción tardía.

2.2 Vía digestiva (ingesta)

- Más del 80–90% pasa espontáneamente al estómago/intestino; 10–20% requiere **endoscopia**; <1% cirugía.
 - Sitios de impactación: **cricofaríngeo (C6)**, **arco aórtico**, **hiato diafragmático**.
 - **Pilas botón** en esófago generan **lesión cáustica por hidrólisis alcalina** y corriente eléctrica local → necrosis licuefactiva en <2 h.
 - **Imanes múltiples** se atraen a través de asas → **necrosis por presión y fístulas**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Aspiración (vía aérea)

Obstrucción completa (asfixia):

- Incapacidad para hablar o toser, **silencio respiratorio**, cianosis, manos al cuello (signo universal).
- Rápida pérdida de conciencia.

Obstrucción parcial:

- **Tos paroxística**, **estridor inspiratorio** (supraglótico/glótico) o **sibilancias focales** (bronquial).
- **Disfonía/afonía**, **babeo** si el CE está en hipofaringe.
- Signos subsiguientes: taquipnea, tiraje, saturación baja.

Después de 24–48 h (aspiración no diagnosticada):

- **Neumonía focal**, fiebre, sibilancias unilaterales, **atelectasia** o hiperinsuflación unilateral (valvular).

3.2 Ingesta (vía digestiva)

CE esofágico:

- **Disfagia/odinofagia, hipersalivación (babeo), dolor retroesternal/cervical, vómitos;** en niños, rechazo alimentario.
- Si complica: fiebre, **dolor torácico severo**, subcutáneo crepitante (enfisema), disnea (compresión).

CE gástrico/intestino:

- Habitualmente asintomático; cólico abdominal si impacta.

3.3 Claves semiológicas para el examen

- **Escuchar estridor (VAS), sibilancias unilaterales** (bronquial).
- **Inspección orofaríngea:** objetos visibles accesibles con pinza **solo si se ven claramente**.
- **Tórax:** asimetría ventilatoria; **hipersonoridad** en pulmón con atrapamiento.
- **Cuello:** dolor focal y enfisema (sugiere perforación esofágica).

3.4 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Distintivo
Asma/broncoespasmo	Sibilancias difusas, historia atópica, respuesta a broncodilatador; no hay “evento súbito” típico.
Laringitis/crup	Tos perruna, estridor con cuadro viral.
Epiglotitis/angioedema	Fiebre o alergia, voz apagada, trípode.
Globo histérico/espasmo esofágico	Disfagia variable sin evento de deglución de objeto.
Cuerpo extraño nasal	Rinorrea unilateral fétida, sin disfagia.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Cuando NO demorar exámenes

- **Obstrucción respiratoria aguda:** actuar de inmediato (maniobras/ vía aérea).
- **Pila botón esofágica:** endoscopia **urgente** sin esperar imágenes si la clínica es inequívoca.

4.2 Imágenes

- **Radiografías:**
 - **Tórax PA y lateral:** atrapamiento aéreo unilateral (hiperinflación), atelectasia, neumonía; objetos **radiopacos** (monedas, pilas).
 - **Cuello AP y lateral:** ubicar CE alto (cricofaríngeo).
 - **Moneda vs pila:** en AP, **moneda** = borde único; **pila** = “**doble contorno/halo**”; en lateral, pila con “**signo del escalón**”.
 - **Moneda en esófago:** en **AP** se ve en **plano frontal**; en **vía aérea** suele verse **de canto** (orientación lateral).
- **No usar contraste baritado** en obstrucción/aspiración.
- **TC:** útil en dudas o CE radiolúcidos (huesos, alimentos), o para complicaciones (perforación).

4.3 Endoscopia diagnóstica

- **Broncoscopía rígida** (preferida en aspiración pediátrica) o **flexible** (adulto estable/CE distal).
- **Endoscopia digestiva alta (EDA)** para esófago/estómago.

4.4 Criterios diagnósticos

- **Aspiración:** evento súbito + tos/estridor/sibilancias unilaterales ± hallazgos Rx → **confirmación por broncoscopía**.
- **Ingesta:** historia + disfagia/babeo/dolor + hallazgo radiológico o **visualización endoscópica**.

5. Tratamiento (según guías y práctica en Chile)

5.1 Principios generales

1. **ABC primero:** asegurar **vía aérea** y **oxigenación**.
 2. **No realizar maniobras “a ciegas”** en orofaringe (riesgo de impactar más).
 3. **Tiempo-dependiente:** pilas y múltiples imanes **son emergencias**.
 4. **Derivación coordinada:** Urgencia/ORL/Anestesia; en esófago, **Gastroenterología**.
-

5.2 Aspiración: algoritmo de desobstrucción

A. Obstrucción completa (asfixia)

- **Lactantes (<1 año):**
 - **5 golpes interescapulares + 5 compresiones torácicas** (dos dedos, línea mamilar), alternar hasta expulsión o inconsciencia.
- **Niños >1 año y adultos conscientes:**
 - **Maniobra de Heimlich** (compresiones abdominales por detrás).
- **Embarazadas/obesos:** compresiones **torácicas** en vez de abdominales.
- **Inconsciente:**
 - Activar RCP: abrir vía aérea, **mirar-aspirar-retirar** si se ve el objeto, **ventilaciones** y **compresiones**; **intubación** por operador entrenado; si **no se puede intubar/ventilar** → **cricotiroidotomía** (adulto) o **cricotiroidotomía con aguja** (niño).

B. Obstrucción parcial (ventila, tose)

- **No intervenir agresivamente;** oxígeno, observación, traslado urgente a centro con broncoscopía.
- **Evitar sedación** que deprima reflejos.

C. Extracción endoscópica

- **Broncoscopía rígida** (elección en pediatría y en CE grandes/afilados proximales).
 - **Broncoscopía flexible** en adultos/CE distales, con canastillas o pinzas.
 - **Corticoides nebulizados/EV** si edema laríngeo pos extracción; **antibióticos** solo si neumonía/atelectasia séptica.
-

5.3 Ingesta: manejo por tipo de objeto

1) Pilas botón

- Si está en esófago → **Endoscopia URGENTE** (ideal <2 h).
- Mantener al paciente **NPO**; **no** administrar eméticos ni neutralizantes caseros.
- Tras extracción: evaluar **lesión mucosa**; vigilancia y dieta progresiva; repetir control si extensa.
- Si ya pasó al estómago y el paciente está asintomático y la pila es **<20 mm**: manejo conservador con **observación y control radiológico** para asegurar progresión (48–72 h). Si **>20–23 mm** o **síntomas**, considerar EDA.

2) Imanes múltiples

- **Emergencia**: si hay **>1 imán** (o imán + objeto metálico) **en cualquier localización**, indicar **endoscopia** si accesible; si distales o signos de abdomen agudo → **cirugía** (riesgo de necrosis por pinzamiento de asas).

3) Monedas/objetos romos en esófago

- **Observación** 12–24 h en asintomáticos (muchas progresan) o **EDA** precoz si dolor/babeo/impactación proximal.
- En pediatría, si persiste >24 h o sintomático → **EDA**.

4) Objetos cortopunzantes / huesos

- **EDA urgente** (alto riesgo de perforación).
- Evitar retrasos y **NO** administrar alimentos “empujadores” (pan, arroz).

5) Impactación alimentaria (bolo cárnico)

- Si obstrucción **alta con sialorrea** → **EDA urgente** (ideal <12 h).
- **Glucagón 1–2 mg IV** puede intentar relajación esofágica en adultos sin contraindicaciones (eficacia limitada); no reemplaza endoscopia.
- Investigación de **anillo de Schatzki/estenosis** posterior.

6) Objetos ya gástricos / intestinales

- **Pequeños, romos**: observación, educación sobre **signos de alarma** (dolor abdominal, hematemesis, fiebre).
 - **>5–6 cm** de largo o **>2–2,5 cm** de diámetro: alto riesgo de no progresar el píloro → considerar **extracción endoscópica** si accesible.
-

5.4 Fármacos y soporte

- **Oxígeno** suplementario.
 - **Adrenalina nebulizada** en edema laríngeo/estridor pos extracción.
 - **Corticoides** (dexametasona EV) si edema significativo.
 - **Antibióticos**: indicados si hay aspiración séptica/neumonía o sospecha de perforación esofágica.
 - **Analgesia** prudente (evitar sedación sin vía aérea segura).
-

5.5 Coordinación y derivación en Chile (práctica habitual)

- **Aspiración**: derivar a **centro con broncoscopia rígida** (ORL o broncopulmonar).
 - **Ingesta esofágica**: derivación a **endoscopia digestiva** (gastroenterología) o **ORL** si alto proximal.
 - **Pilas/imanes**: notificar **urgencia inmediata**; priorizar pabellón.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Escenario	Complicaciones
Aspiración	Hipoxia, paro cardiorrespiratorio, neumonía localizada, atelectasia, bronquiectasias (CE tardío), hemoptisis, estenosis bronquial por granulación.
Pila esofágica	Necrosis en <2 h, perforación, fístula traqueoesofágica o atrioesofágica (hemorragia catastrófica), mediastinitis.
Imanes múltiples	Fístulas enteroentéricas, perforación, peritonitis.
Objetos cortopunzantes	Perforación esofágica, absceso cervical/mediastínico, sepsis.
Bolo alimentario	Necrosis por presión, aspiración secundaria.

Pronóstico: Excelente con **desobstrucción precoz** y extracción endoscópica oportuna. La mortalidad se asocia a **asfixia prehospitalaria** y a **demoras** en pilas/imanés.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Asfixia súbita + silencio respiratorio = maniobras de desobstrucción inmediatas** según edad; si falla → **crico** de rescate.
2. **Moneda** en esófago (AP): **plano frontal**; en vía aérea: **de canto**.
3. **Pila botón en esófago = quirófano ahora** (daño en <2 h).
4. **Imanes múltiples** son tan urgentes como las pilas.

5. En aspiración pediátrica tardía, **hiperinsuflación unilateral** en espiración sugiere CE.
6. **Broncoscopía rígida** es preferida en niños y CE proximales grandes.
7. **No “barrer” a ciegas** la orofaringe; solo retirar objetos **visibles** con pinza de Magill bajo visión.
8. Bolo cárnico: **EDA** precoz; el **glucagón** puede intentarse, pero **no retrasa** endoscopia.

Errores comunes

- Enviar a Rx a un paciente **asfixiándose** (primero desobstruir/asegurar vía aérea).
 - **Presionar epigastrio** en lactantes (es **golpes + compresiones torácicas**, no Heimlich abdominal).
 - Retrasar extracción de **pila** por trámites/ayuno.
 - Usar **bario** o contrastes en obstrucción.
 - Intentar **empujar** el CE con alimentos/bebidas carbonatadas (riesgo de perforación/aspiración).
 - Sedar un paciente con **obstrucción parcial** sin plan de vía aérea.
 - Dar de alta **monedas esofágicas** sin control o plan.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Aspiración y ingesta** de cuerpos extraños son urgencias frecuentes; la primera puede causar **asfixia inmediata**.
2. **Algoritmo vital: ABC**, desobstrucción según edad (golpes/compresiones en lactantes, **Heimlich** en >1 año/adultos), y **cricotiroidotomía** si no se puede ventilar/intubar.
3. **Broncoscopía rígida** (niños/CE grandes) o **flexible** (adultos/CE distales) para extracción; evitar maniobras a ciegas.

4. **Pila botón esofágica e imanes múltiples** son **emergencias tiempo-dependientes** → **endoscopia inmediata**.
5. **Radiología** orienta: hiperinsuflación unilateral (aspiración), **doble contorno** (pila), **orientación frontal** de moneda en esófago.
6. Bolo alimentario: **EDA** precoz; el glucagón puede usarse, pero **no reemplaza** endoscopia.
7. El pronóstico depende de la **rapidez de desobstrucción** y extracción; retrasos aumentan mortalidad y complicaciones (fístulas, perforación, mediastinitis).